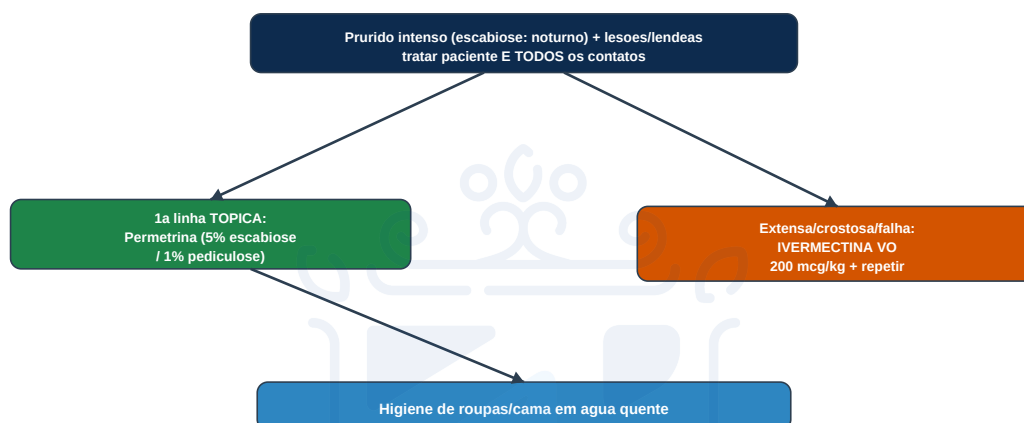


ECTOPARASITOSE — ESCABIOSE + PEDICULOSE

FLUXOGRAMA — ABORDAGEM

ECTOPARASITOSE — PERMETRINA + TRATAR CONTATOS



ESCABIOSE (SARNA)

SARCOPTES SCABIEI

- Ectoparasitose pelo ácaro *Sarcoptes scabiei* var. *hominis*; transmissão por contato direto e prolongado pele a pele (surto familiares/institucionais)
- PRURIDO INTENSO de predomínio NOTURNO + pápulas/vesículas/escoriações e SULCOS acarinos
- Distribuição típica: espaços interdigitais, punhos, cotovelos, axilas, periumbilical, genitais, nádegas (lactentes: face/couro cabeludo)
- Formas: clássica, nodular e CROSTOSA (norueguesa) — grave, hiperqueratótica, altíssima carga parasitária, pouco prurido, MUITO contagiosa (idosos/imunossuprimidos)
- Prurido pode persistir 2-4 semanas após a cura (hipersensibilidade residual) ≠ falha terapêutica

PEDICULOSE

PIOLHOS (PEDICULUS/PTHIRUS)

- Ectoparasitose por piolhos hematófagos; prurido, lesões e potencial infecção secundária; transmissão por contato direto (higiene NÃO é fator determinante)
- Tipos: CAPITIS (couro cabeludo, mais comum — lêndeas aderidas ao fio, região occipital/retroauricular); CORPORIS (corpo/costuras das roupas); PUBIS/ftíriase (região pubiana, pode acometer cílios)
- Pediculose capitis é frequente em crianças e ambientes coletivos (escolas/creches)
- Sinais: prurido, piolhos vivos, lêndeas, escoriações, crostas melicéricas (impetiginização)
- Pediculose pubis: avaliar/tratar ISTs associadas e tratar parceiros sexuais

TRATAMENTO TÓPICO (1ª LINHA)

Rx PERMETRINA

ESCABIOSE — Permetrina 5% creme (padrão-ouro): aplicar à noite sobre pele seca, do PESCOÇO PARA BAIXO (incluir dobras, genitais, interdigitais); em lactentes/idosos/crostosa incluir couro cabeludo e face (evitar olhos/boca); manter 8-12h, lavar pela manhã; REPETIR após 7 dias

PEDICULOSE — Permetrina 1% (loção/shampoo): aplicar no couro cabeludo úmido, agir 10 min, enxaguar; REPETIR em 7-10 dias; remoção mecânica das lêndeas com pente fino

Pediculose corporis: banho diário + troca/lavagem das roupas em água quente (tópico só se necessário)

Controle do prurido: Loratadina 10 mg/dia; Hidroxizina 25 mg à noite; corticoide tópico leve por curto período

Infecção bacteriana secundária (impetigo/celulite): antibiótico sistêmico + cuidados locais

TRATAMENTO SISTÊMICO — IVERMECTINA

Rx QUANDO USAR

Indicações: falha do tópico, escabiose CROSTOSA/extensa, infestações extensas, surtos institucionais, dificuldade de adesão ao tópico

Dose: 200 mcg/kg VO em dose única; REPETIR após 7-14 dias (escabiose) / 7-10 dias (pediculose)

CONTRAINDICAÇÕES: crianças < 15 kg, gestantes (lactação: avaliar risco/benefício)

ESCABIOSE CROSTOSA (protocolo específico): Permetrina 5% diária por 7 dias e depois 2x/semana até resolver + Ivermectina nos dias 1, 2, 8, 9 e 15 + ISOLAMENTO de contato + avaliar internação + notificar CCIH/vigilância

Não confundir prurido residual pós-tratamento com falha

CONTATOS, ALTA E INTERNAÇÃO

MEDIDAS-CHAVE

- ☐ TRATAR TODOS os contatos domiciliares SIMULTANEAMENTE (mesmo assintomáticos)
- ☐ Lavar roupas, toalhas e roupas de cama em ÁGUA QUENTE; itens não laváveis -> isolar por 72h (escabiose) / 48-72h (pediculose); cortar unhas; não compartilhar pentes/bonés/toalhas
- ☐ INTERNAR: escabiose crostosa, infecção secundária extensa, comprometimento sistêmico, imunossuprimidos graves, incapacidade de tratamento domiciliar, necessidade de isolamento hospitalar
- ☐ ALTA: diagnóstico definido, tratamento iniciado, orientações completas, sem critério de internação, seguimento definido
- ☐ Escabiose e pediculose NÃO são de notificação compulsória; surtos institucionais devem ser comunicados à vigilância sanitária

MODELO DE REGULAÇÃO / ENCAMINHAMENTO

RESUMO PARA ENCAMINHAMENTO

- Paciente ____ anos com ____ (escabiose clássica/nodular/CROSTOSA / pediculose capitis/corporis/pubis); prurido ____ ; contatos sintomáticos ____.
- Gravidade: forma crostosa ____, infecção secundária ____, imunossupressão ____; institucionalizado ____.
- Conduta: Permetrina ____, Ivermectina ____ (se indicado), anti-histamínico; ATB se impetiginização ____.
- Tratar contatos + higiene de roupas/cama; solicito internação/isolamento se crostosa/infecção extensa; comunicar vigilância se surto.

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Qual é o tratamento tópico de primeira linha (padrão-ouro) da escabiose?

- A) Permetrina 5% creme
- B) Corticoide tópico
- C) Antibiótico tópico
- D) Cetoconazol
- E) Ácido salicílico

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Em qual situação está indicada a ivermectina oral nas ectoparasitoses?

- A) Em todo caso leve
- B) Falha do tópico, escabiose crostosa/extensa, surtos institucionais ou dificuldade de adesão
- C) Apenas em gestantes
- D) Em crianças < 15 kg
- E) Nunca

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Qual forma de escabiose é grave, hiperqueratótica e altamente contagiosa, comum em imunossuprimidos?

- A) Escabiose nodular
- B) Escabiose crostosa (norueguesa)
- C) Escabiose clássica
- D) Pediculose capitis
- E) Ftíriase

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Qual medida é essencial para evitar a reinfestação nas ectoparasitoses?

- A) Tratar apenas o paciente
- B) Tratar todos os contatos domiciliares simultaneamente e higienizar roupas/cama em água quente
- C) Isolamento hospitalar de rotina
- D) Antibiótico para todos
- E) Repouso absoluto

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

O prurido que persiste por 2-4 semanas após o tratamento adequado da escabiose indica:

- A) Falha terapêutica obrigatória
- B) Reação de hipersensibilidade residual (não é falha); tratar com anti-histamínico
- C) Necessidade de antibiótico
- D) Resistência ao tratamento
- E) Reinfecção sempre

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: A

A permetrina 5% creme é o tratamento tópico padrão-ouro da escabiose (aplicar do pescoço para baixo, manter 8-12h, repetir em 7 dias).

QUESTÃO 2 → Resposta: B

A ivermectina oral (200 mcg/kg, repetir) é indicada na falha do tópico, escabiose crostosa/extensa, surtos institucionais ou dificuldade de adesão; é contraindicada em < 15 kg e gestantes.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

A escabiose crostosa (norueguesa) é a forma grave, hiperqueratótica, com altíssima carga parasitária e muito contagiosa, típica de idosos e imunossuprimidos.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Tratar todos os contatos domiciliares simultaneamente e higienizar roupas/toalhas/cama em água quente é essencial para evitar a reinfestação.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

O prurido residual por 2-4 semanas é reação de hipersensibilidade ao ácaro, não falha terapêutica; trata-se com anti-histamínico (± corticoide tópico leve por curto período).

SM24
Suporte ao Plantão Médico